

GUIA PRÁTICO · PSICOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIA

7 sinais de que sua mente está *pedindo ajuda*

Um guia curto e honesto para reconhecer o que o cansaço já vinha tentando dizer — e o que fazer a partir de hoje.

LEITURA EM 12 MINUTOS

Wesley Rossi Rodrigues · Psicólogo Clínico

CRP 19065-1 · OPP 23365 · EuroPsy PT-061398-201909

Atendimento online em português · psicologiasupernova.com.br

Psicologia, ciência com evidência.

Você não está exagerando.

Se você chegou até aqui, é provável que já tenha ouvido alguma versão de “é só uma fase”, “todo mundo está cansado” ou “tenta descansar mais”. Essas frases não são maldosas — apenas insuficientes.

O sofrimento psíquico raramente chega como um evento. Ele chega como **uma sequência de pequenas concessões**: o sono que encurtou, o prazer que esfriou, a paciência que ficou curta, o corpo que passou a doer sem explicação.

Este guia não substitui avaliação clínica e não entrega diagnóstico. Ele faz algo mais simples e mais urgente: **devolve nome ao que você está sentindo**. Porque aquilo que ganha nome pode ganhar cuidado.

Nomear é o primeiro ato terapêutico. Só cuidamos daquilo que conseguimos reconhecer.

Como usar este material

- Leia sem pressa e sem se autodiagnosticar.
- Em cada sinal, responda à **pergunta-chave** com sinceridade.
- Anote quantos sinais aparecem **há mais de duas semanas**.
- Ao final, use o **mapa de apoio** para decidir o próximo passo.

IMPORTANTE

Se houver pensamentos de morte, de desaparecer ou de se machucar, **não espere pelo fim da leitura**. No Brasil, ligue **188 (CVV)**, 24h, gratuito. Em Portugal, **SNS 24 — 808 24 24 24**. Em emergência: **192 (BR)** ou **112 (PT)**.

Os sete sinais

- 01 O sono deixou de restaurar
- 02 A irritabilidade virou o tom padrão
- 03 O prazer perdeu cor
- 04 O corpo começou a falar
- 05 A concentração escapa
- 06 O contato com pessoas pesa
- 07 Você funciona, mas não está presente

E depois

- Mapa de apoio: o que fazer em cada cenário
- Sobre o autor e credenciais
- Como iniciar um acompanhamento

CRITÉRIO CLÍNICO

Sinais isolados fazem parte da vida. O que pede atenção é a **persistência** (duas semanas ou mais), a **intensidade** e, sobretudo, o **prejuízo funcional** — quando trabalho, relações ou autocuidado começam a ser afetados.

O sono deixou de restaurar

Dormir e descansar não são a mesma coisa. Você pode passar oito horas na cama e acordar como se tivesse trabalhado a noite inteira. Isso não é preguiça — é um dado clínico.

O QUE APARECE	O QUE COSTUMA INDICAR
Demora acima de 30 min para adormecer	Ativação fisiológica e ruminação noturna
Despertares às 3h–4h sem voltar a dormir	Padrão frequente em quadros depressivos
Acordar exausto após noite completa	Sono fragmentado, sem fases profundas
Dormir demais e ainda sentir peso	Sono como fuga do estado emocional

PERGUNTA-CHAVE

Nos últimos 14 dias, quantas manhãs você acordou sentindo que realmente descansou?

PRIMEIRO PASSO

Antes de mudar o sono, **observe-o**. Por sete dias registre: hora de deitar, tempo estimado para dormir, despertares e sensação ao acordar (0 a 10). Esse registro simples vale mais em consulta do que qualquer estimativa de memória.

A irritabilidade virou o tom padrão

Existe um mal-entendido cultural: sofrimento psíquico associado apenas à tristeza. Na prática clínica, **irritabilidade é uma das apresentações mais frequentes** — especialmente em homens, adolescentes e pessoas com alta carga de responsabilidade.

Quando o sistema nervoso opera em sobrecarga contínua, a margem de tolerância encurta. Barulho incomoda mais, atraso irrita mais, pergunta simples parece cobrança.

Como isso se manifesta

- Reações desproporcionais a estímulos pequenos
- Culpa logo após a explosão — e depois isolamento
- Sensação de estar “sempre na defensiva”
- Impaciência com quem você mais ama

PERGUNTA-CHAVE

As pessoas próximas passaram a medir palavras perto de você?

LEITURA CLÍNICA

Irritabilidade persistente não é falha de caráter. É, com frequência, **um pedido de socorro sem vocabulário**. Tratar a irritabilidade sem cuidar da sobrecarga que a sustenta é apagar o alarme e deixar o incêndio.

O prazer perdeu cor

Há um estado em que nada dá exatamente errado — e nada dá exatamente certo. A música que emocionava agora é só som. O encontro que animava virou compromisso. Em psicopatologia, chamamos essa redução da capacidade de sentir prazer de **anedonia**.

Ela é discreta e por isso perigosa: raramente gera crise, apenas **esvaziamento progressivo**. A pessoa continua funcionando, cumpre o que precisa, e vai perdendo o motivo pelo qual fazia.

Não é que doa muito. É que já não importa — e isso é mais grave do que parece.

Teste simples

- Liste três atividades que te davam prazer há dois anos.
- Marque quais você manteve nos últimos 30 dias.
- Das mantidas, quais ainda produzem alguma vibração interna?

PERGUNTA-CHAVE

Quando foi a última vez que você sentiu entusiasmo genuíno por algo?

PRIMEIRO PASSO

Não espere a vontade voltar para agir. Em terapia usamos o caminho inverso — **ativação comportamental**: a ação vem primeiro, o afeto responde depois. Comece com 15 minutos de algo que já teve significado, mesmo sem vontade.

O corpo começou a falar

Quando o sofrimento não encontra palavra, ele encontra órgão. Exames normais e sintomas reais convivem com frequência — e isso não significa que “é da sua cabeça”. Significa que **o corpo está participando do quadro emocional**.

MANIFESTAÇÃO	CONTEXTO FREQUENTE
Tensão cervical e mandíbula travada	Ansiedade sustentada, bruxismo noturno
Aperto no peito, falta de ar	Hiperventilação, resposta de ameaça
Alterações intestinais recorrentes	Eixo intestino–cérebro em desregulação
Dores difusas e fadiga persistente	Estresse crônico, exaustão
Apetite muito acima ou abaixo	Regulação emocional pela comida

PERGUNTA-CHAVE

Você tem sintoma físico recorrente que já foi investigado e não teve causa orgânica encontrada?

ORDEM CORRETA

Sempre **investigue clinicamente primeiro**. Descartada a causa orgânica, o sintoma não deixa de existir — ele apenas muda de endereço terapêutico. O melhor cuidado nesses casos é conjunto: médico e psicólogo, na mesma direção.

A concentração escapa

Você lê o mesmo parágrafo três vezes. Entra numa sala e esquece o motivo. Abre uma aba para resolver algo e termina em outra, sem lembrar do início.

Atenção e memória de trabalho são **funções altamente sensíveis ao estado emocional**. Quando ansiedade ou depressão ocupam recursos cognitivos, sobra menos capacidade para o resto. Não é falta de inteligência nem de disciplina: é **banda cognitiva ocupada**.

O que costuma acontecer

- Queda de produtividade com aumento de horas trabalhadas
- Erros em tarefas antes automáticas
- Dificuldade de decidir coisas simples
- Autocrítica severa — que consome ainda mais atenção

PERGUNTA-CHAVE

Você está trabalhando mais horas para entregar menos do que entregava antes?

PRIMEIRO PASSO

Reduza a demanda antes de exigir desempenho. Trabalhe em **blocos de 25 minutos com pausa real** — sem tela — e faça uma única tarefa por bloco.

Multitarefa, em estado de sobrecarga, é a forma mais rápida de esgotar o que ainda resta.

O contato com pessoas pesa

O isolamento raramente é uma decisão. Ele é um processo: primeiro você desmarca uma vez, depois responde mais devagar, depois começa a preferir o silêncio — e, em algum ponto, a solidão que era alívio passou a ser cárcere.

Existe uma diferença clínica importante entre **recolhimento restaurador** e **retração defensiva**. O primeiro devolve energia. O segundo consome, mas parece mais seguro do que se expor.

Quando estar entre pessoas passa a custar mais do que rende, o vínculo deixou de sustentar — e passou a ser esforço.

Sinais de retração

- Alívio ao ver um plano cancelado
- Mensagens acumuladas por dias sem resposta
- Sensação de precisar “atuar” para conviver
- Vergonha de mostrar como você realmente está

PERGUNTA-CHAVE

Há quanto tempo você não conversa com alguém sobre como está de verdade?

PRIMEIRO PASSO

Escolha **uma pessoa** e um contato de baixo custo — uma mensagem de áudio, uma caminhada de vinte minutos. Reconexão não se faz por grandes gestos; ela se refaz por **exposição gradual e segura**.

Você funciona, mas não está presente

Este é o sinal mais silencioso e o mais subestimado. A pessoa cumpre horários, entrega resultados, sustenta a casa — e, por dentro, opera no piloto automático. É a chamada **depressão funcional**: alta performance externa, esvaziamento interno.

Justamente porque funciona, ninguém percebe. E porque ninguém percebe, ela demora anos para ser cuidada.

DO LADO DE FORA	DO LADO DE DENTRO
Responsável, produtivo, confiável	Vazio, automático, distante
"Está tudo bem"	Cansaço que dormir não resolve
Agenda cheia	Sensação de assistir à própria vida
Apoia todos ao redor	Não sabe a quem recorrer

PERGUNTA-CHAVE

Se você parasse hoje, sobraria alguma coisa além das suas funções?

LEITURA CLÍNICA

Aguentar não é o mesmo que estar bem. **Capacidade de suportar não é indicador de saúde mental** — muitas vezes é o que mais adia o cuidado. Não é preciso desabar para merecer atenção.

DEPOIS DA LEITURA

Mapa de apoio

Conte quantos sinais estão presentes **há duas semanas ou mais** e localize seu cenário. Este mapa orienta a próxima ação — não define diagnóstico.

SINAIS	PRÓXIMO PASSO RECOMENDADO
0 a 1	Cenário de manutenção. Preserve sono, movimento e vínculos. Reavalie em 30 dias.
2 a 3	Sinal de alerta inicial. Reduza carga, retome rotina básica e considere avaliação psicológica preventiva.
4 a 5	Sobrecarga significativa. Busque acompanhamento psicológico regular — não aguarde melhora espontânea.
6 a 7	Alta probabilidade de prejuízo funcional. Procure avaliação psicológica e clínica com prioridade.

Canais de apoio imediato

- **CVV — 188** · Brasil · 24h, gratuito, sigiloso · [cvv.org.br](https://www.cvv.org.br)
- **SNS 24 — 808 24 24 24** · Portugal · linha de saúde 24h
- **CAPS** · Brasil · atendimento público em saúde mental
- **Emergência** · 192 (SAMU/BR) · 112 (PT)

UM CRITÉRIO SÓ

Você não precisa atingir número mínimo de sinais para pedir ajuda.

Sofrimento é critério suficiente. Se algo aqui te reconheceu, isso já basta como motivo.

SOBRE O AUTOR



Wesley Rossi Rodrigues

Psicólogo Clínico · Formação em Psicologia no Brasil e na Europa

CRP 19065-1 · Brasil

OPP 23365 · Portugal

EuroPsy PT-061398-201909

EMDR

Neurociência

Mestrando em Psicologia da Educação

Atuo com adultos em processos de ansiedade, depressão, trauma e esgotamento, em atendimento online em português para o Brasil, Portugal e brasileiros no exterior. Meu compromisso é com prática clínica **baseada em evidência**, sem promessas fáceis e sem linguagem inflada.

REGISTROS PROFISSIONAIS

CRP 19065-1 — Conselho Federal de Psicologia (Brasil)

OPP 23365 — Ordem dos Psicólogos Portugueses

EuroPsy Nº PT-061398-201909 — Certificado Europeu de Psicologia

PRÓXIMO PASSO

Quer conversar sobre o que você reconheceu aqui?

A primeira sessão é uma conversa de avaliação: entender o seu momento, o que já tentou e definir juntos se e como seguir. Sem compromisso de continuidade.

MODALIDADE	Online · em português
ATENDIMENTO	Brasil · Portugal · exterior
REGISTROS	CRP 19065-1 · OPP 23365
CERTIFICAÇÃO	EuroPsy PT-061398-201909
SITE	psicologiasupernova.com.br

Agendar avaliação inicial

Este material tem caráter informativo e educativo. Não constitui diagnóstico, tratamento ou substituição de avaliação profissional individualizada. Em situação de risco, procure atendimento imediato: **188 (CVV)** ou **192** no Brasil; **808 24 24 24** ou **112** em Portugal.

© Wesley Rossi Rodrigues · Psicologia Supernova · Todos os direitos reservados.